

Bir üniversite hastanesine bağlı sigara bırakma polikliniğine başvuran hastaların demografik ve klinik özellikleri ile sigara bırakma durumlarını etkileyen faktörler

Emre Cenberlitaş¹, Aksanur Gökçe², Onur Öztürk³

¹İstanbul Beylikdüzü Kavaklı 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi (Birim: 34.12.035), İstanbul, Türkiye

²Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Amasya, Türkiye

³Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Amasya, Türkiye

ÖZ

Amaç: Sigara bağımlılığı, önlenabilir ölüm nedenlerinin başında gelen ve tüm yaş gruplarını etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Çalışmamızda, bir üniversite hastanesine bağlı sigara bırakma polikliniğine başvuran hastaların demografik ve klinik özelliklerinin ve sigara bırakma durumlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu çalışma retrospektif, kesitsel bir çalışmadır. 01 Ağustos 2020 ile 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı sigara bırakma polikliniğine başvuran hastaların yaş, cinsiyet, meslek, kronik hastalık durumu, uygulanan tedaviler, sigara içme öyküleri ve Fagerström puanları, kişisel bilgileri paylaşılmaksızın hastane otomasyon sistemi aracılığıyla elde edilmiştir. Veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Çalışmaya toplam 399 hasta dahil edildi. Hastaların %63,66'sı (n=275) erkekti. Hastaların ortalama Fagerström puanı $5,66 \pm 2,43$ olarak hesaplandı. Hasta başına ortalama $2,21 \pm 1,28$ görüşme yapıldı. Hastaların ortalama sigara içme süresi $27,38 \pm 16,57$ paket-yıl olarak hesaplandı. Hastaların %35,19'unda (n=141) kombine tedavi başlandı. Kombine tedavi olarak hastaların %88,15'ine (n=134) Bupropion ve Nikotin Replasman Tedavisi (NRT) kombinasyonu başlandı. Tedavi sonucunda hastaların %34,09'u (n=136) sigarayı bıraktı. Bupropion monoterapisi, sigara bırakmada en az etkili ilaç olarak bulundu ($p=0,01$). Kombine tedavi alan hastalarda sigara bırakma oranı diğer tedavi seçeneklerine göre daha yüksek bulundu ($p<0,001$). Sigarayı bırakan hastaların Fagerström puanı bırakmayanlara göre anlamlı derecede düşükken ($p=0,024$), hasta başına düşen bireysel görüşme sayısı ($p<0,001$) anlamlı derecede yüksekti. Hanesinde sigara içen başka birinin bulunduğu hastaların oranı, sigarayı bırakanlarda bırakmayanlara göre daha düşüktü ($p=0,003$).

Sonuç: Hastaların yaklaşık üçte birinin sigarayı bıraktığı gözlemlendi. Kombine tedavi kullanan hastaların sigara bırakma oranı diğer tedavi seçeneklerine göre daha yüksek bulundu.

Anahtar kelimeler: bupropion, nikotin replasman tedavisi, sigara bırakma, sitizin, vareniklin

✉ Aksanur Gökçe • aksanurgokce@gmail.com

Geliş: 29.09.2025 Kabul: 11.03.2026 Yayın: 30.06.2026

Telif Hakkı © 2026 Yazar(lar). Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (Turkish Association of Family Physicians) tarafından yayımlanmıştır. Bu makale, uygun atıf yapılması koşuluyla her ortam ve formatta sınırsız kullanım, dağıtım ve çoğaltmaya izin veren [Creative Commons Atıf Lisansı \(CC BY\)](#) kapsamında yayımlanan açık erişimli bir makedir.

Çeviri notu: Bu belge, yukarıda künyesi verilen İngilizce makalenin Türkçe çevirisidir; orijinal makale yerine geçmez ve atıflarda özgün yayın esas alınmalıdır. Özgün kaynak: Cenberlitaş E, Gökçe A, Öztürk O. Demographic and clinical characteristics of patients applying to a smoking cessation clinic affiliated with a university hospital and factors affecting their smoking cessation status. Turk J Fam Pract 2026;30(2):97-106. DOI: 10.54308/TJFP.2026.912. Çeviride ondalık ayırıcı olarak Türkçe yazım kuralına uygun biçimde virgül kullanılmıştır.

Giriş

Tütün bağımlılığı, tüm yaş gruplarını etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur ve dünya genelinde önlenabilir ölüm nedenlerinin başında gelmeye devam etmektedir.^[1] Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki erken ölümlerin yaklaşık %80'inden sorumludur.^[2,3] Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Türkiye 2016 verilerine göre sigara içme prevalansı erkeklerde %44,1, kadınlarda %19,2'dir.^[4]

Sigara bırakmada bireyin kararı, tutumları ve davranışları belirleyici rol oynar. Profesyonel yardım gerektiğinde yapılandırılmış tedavi, bırakma şansını büyük ölçüde artırır.^[5] Bununla birlikte sigara bırakma danışmanlığı sunmak, nikotin bağımlılığının kendisi kadar karmaşık ve zorludur. Türkiye'de 500'den fazla sigara bırakma polikliniği hizmet vermekte olup 2,5 milyondan fazla kişi sigara bırakma danışmanlığı almak için başvurmuştur.^[6] Türkiye'de sigara bırakma polikliniklerine başvuran bireylerin bırakma oranları %20 ile %50 arasında değişmektedir.^[7]

Türkiye'de düşük nikotin bağımlılığı, sağlık profesyonelleri tarafından düzenli takip, farmakolojik tedaviye uyum ve güçlü sosyal destek dahil olmak üzere birçok faktör sigara bırakma başarısını etkilemektedir.^[8,9]

Tedavi stratejileri hem davranışsal yaklaşımlardan hem de farmakoterapiden oluşur. Sağlık İnanç Modeli, Sağlık Kontrol Odağı, Yeniliklerin Yayılımı Modeli, Pender'in Sağlığı Geliştirme Modeli ve Transteorik Model, yaygın olarak uygulanan davranış değişikliği modelleri arasındadır.^[10,11] Farmakoterapi temel olarak nikotin replasman tedavisi (NRT – transdermal bant, sakız, burun spreyi, inhaler, dil altı tablet ve pastil), bupropion ve vareniklin'den oluşur. Sitizin yakın zamanda ek bir farmakoterapi seçeneği olarak kullanıma sunulmuştur.^[12] Farmakoterapi uygulanırken ideal olarak davranışsal müdahalelerle desteklenmeli ve gerektiğinde kombine tedaviler düşünülmelidir.^[5]

Bu çalışmada, bir üniversite hastanesi sigara bırakma polikliniğine başvuran bireylerde kombine tedavi ve yakın takibin sigara bırakma başarısı üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçladık. Bu hastaların özelliklerini ve bırakma sonuçlarını etkileyen faktörleri analiz ederek, gelecekte başvuracak kişiler için tedavi kararlarına yol gösterebilecek kanıtlar sunmayı hedefliyoruz.

Gereç ve Yöntem

Çalışma tasarımı ve popülasyonu

Bu çalışma kesitsel, retrospektif bir analiz olarak tasarlandı. Çalışma popülasyonu, 1 Ağustos 2020 ile 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniği'ne gönüllü olarak başvuran, sigara içen ve ≥ 18 yaşındaki 432 hastadan oluştu. Mevcut tüm hasta kayıtları dahil edildiğinden örneklem büyüklüğü hesaplaması yapılmadı.

Veri toplama

Yaş, cinsiyet, meslek, alkol kullanımı, kronik hastalık varlığı, tedavi yöntemleri ve sigara öyküsü (paket-yıl) dahil demografik ve klinik veriler hastaların tıbbi kayıtlarından elde edildi. Her hastanın, ilk görüşmeye ve sonraki takip seanslarına ait verilerin belgelendiği bireysel bir dosyası vardı. Sigara bırakma danışmanlığı, sigara bırakma tedavisi sertifikasına sahip hekimler ve eğitim almış asistan hekimler tarafından verildi.

İlk vizitte nikotin bağımlılığı, Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT; Fagerström Test for Nicotine Dependence, FTND) ile değerlendirildi. 0–2 puan düşük, 3–7 puan orta ve 8–10 puan yüksek bağımlılık olarak sınıflandırıldı.^[13] FNBT'nin Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması 2004 yılında Uysal ve ark. tarafından yapılmış olup Cronbach alfa değeri 0,56 olarak bildirilmiştir.^[14]

Tedavi stratejileri FNBT puanlarına, kronik hastalık durumuna, eşzamanlı ilaç kullanımına, farmakoterapi kontrendikasyonlarına ve hasta uyumuna göre bireyselleştirildi. Hastalar yalnızca davranışsal tedavi, monoterapi (vareniklin, bupropion, sitizin, nikotin replasman tedavisi [NRT]) veya kombine tedavi (bupropion+NRT, vareniklin+NRT, sitizin+NRT ya da üçlü tedavi) aldı. Sağlık Bakanlığı politikaları doğrultusunda NRT ve sitizin belirli dönemlerde ücretsiz olarak sağlandı. Takip vizitleri hasta dosyalarına kaydedildi.

432 hasta dosyası mevcut olmasına rağmen 399 hastanın verilerine eksiksiz ulaşılabildi ve bu hastalar nihai analize dahil edildi. 31 Ağustos 2024 itibarıyla en az bir yıllık takibini tamamlamamış olan hastalar ile sigarayı bırakmayan hastalar analiz dışı bırakıldı. Yıllık kontrol vizitlerini kaçıran hastaların takip bilgileri, asistan hekimler tarafından yapılan uzaktan görüşmelerle elde edildi.

Etik hususlar

Çalışma protokolü için Etik Kurul onayı Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden alındı (Onay No: 2023/18/10,

tarih: 4 Ekim 2023). Tüm hastalardan ilk başvurularında yazılı bilgilendirilmiş onam alındı.

İstatistiksel analiz

İstatistiksel analizler SPSS 25.0 sürümü kullanılarak yapıldı. Dağılımın normalliği histogram grafikleri ve Kolmogorov-Smirnov testi ile değerlendirildi. Tanımlayıcı istatistikler ortalama $\pm$ standart sapma, ortanca ve minimum-maksimum değerler olarak sunuldu. Kategorik değişkenler ki-kare testi ile karşılaştırıldı. Normal dağılım göstermeyen sürekli değişkenler, iki grup karşılaştırmalarında Mann-Whitney U testi, ikiden fazla grup karşılaştırmalarında ise Kruskal-Wallis testi ile analiz edildi. $p < 0,05$ değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Anlamlı sonuçlar için post-hoc ikili karşılaştırmalar Duncan testi ile yapıldı. Tedavi yöntemlerinin sigara

bırakma sonuçları üzerindeki etkisini değerlendirmek için ikili (binary) lojistik regresyon analizi yapıldı ve Bonferroni düzeltmesi uygulandı (düzeltilmiş anlamlılık düzeyi: $p < 0,003$).

Bulgular

Analize toplam 399 hasta dahil edildi. Katılımcıların yaş ortalaması $44,69 \pm 12,05$ yıl, ortanca yaş 44 (aralık: 18–74) idi. Çalışma popülasyonunun sosyodemografik özellikleri Tablo 1'de sunulmuştur. Sosyodemografik özellikler ile sigara bırakma durumu arasındaki karşılaştırmalar Tablo 2'de gösterilmiştir. Hanede sigara içen başka birinin bulunması, başarılı bırakma olasılığının anlamlı derecede daha düşük olmasıyla ilişkilirdi ($p = 0,003$). Benzer şekilde, sigaraya bağlı yakınma bildiren katılımcıların bırakma oranları daha düşüktü ($p = 0,026$).

Tablo 1. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri

Özellik	Kategori	n	%
Cinsiyet	Kadın	145	(36,34)
	Erkek	254	(63,66)
Yaş grubu (yıl)	<25	20	(5,01)
	26–44	182	(45,61)
	45–60	147	(36,84)
	61–75	50	(12,54)
Medeni durum	Evli	327	(81,96)
	Bekâr/Hiç evlenmemiş	51	(12,78)
	Dul	21	(5,26)
Eğitim durumu	İlköğretim	95	(23,81)
	Ortaöğretim	131	(32,83)
	Yükseköğretim	173	(43,36)
Yerleşim yeri	İl merkezi	343	(85,96)
	Kırsal/İl dışı	56	(14,04)
Çalışma durumu	Memur	135	(33,83)
	İşsiz/Ev hanımı/Emekli/Öğrenci	137	(34,34)
	İşçi	50	(12,53)
	Özel sektör	77	(19,30)
Hanede başka sigara içen varlığı	Evet	158	(39,60)
	Hayır	241	(60,40)
Toplam		399	100,00

Tablo 2. Hastaların sosyodemografik özelliklerine göre sigara bırakma sonuçlarının karşılaştırılması

Özellik	Başarısız n (%)	Başarılı n (%)	p
Cinsiyet			0,331
Kadın	100 (68,97)	45 (31,03)	
Erkek	163 (64,18)	91 (35,82)	
Yaş grubu			0,587
<25	15 (75,00)	5 (25,00)	
26–44	115 (63,20)	67 (36,80)	
45–60	101 (68,70)	46 (31,30)	
61–75	32 (64,00)	18 (36,00)	
Medeni durum			0,614
Evli	219 (67,20)	107 (32,80)	
Bekâr/Hiç evlenmemiş	31 (60,78)	20 (39,22)	
Dul	13 (61,90)	8 (38,10)	
Eğitim durumu			0,632
İlköğretim	66 (69,47)	29 (30,53)	
Ortaöğretim	83 (63,36)	48 (36,64)	
Yükseköğretim	114 (65,93)	59 (34,07)	
Yerleşim yeri			0,169
İl merkezi	220 (64,17)	123 (35,83)	
Kırsal/İl dışı	43 (76,79)	13 (23,21)	
Çalışma durumu			0,719
Memur	87 (64,44)	48 (35,56)	
İşsiz/Ev hanımı/Emekli/Öğrenci	88 (64,23)	49 (35,77)	
İşçi	33 (66,00)	17 (34,00)	
Özel sektör	55 (71,43)	22 (28,57)	
Hanede başka sigara içen			0,003
Hayır	145 (60,16)	96 (39,84)	
Evet	118 (74,68)	40 (25,32)	
Alkol kullanımı			0,273

Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi (FNBT) puanlarına göre katılımcıların %13,19'u (n = 57) düşük, %61,34'ü (n = 265) orta ve %25,46'sı (n = 110) yüksek nikotin bağımlılığına sahipti. Katılımcıların çoğunluğu (%75,69, n = 327) daha önce sigarayı bırakmayı denemiş olup bunların %49,85'i (n = 163) bu denemeler sırasında profesyonel destek almıştı. Hastaların toplam %7,19'u (n = 31) sigara dışında tütün ürünleri kullandığını bildirdi; bunlar arasında elektronik sigara (%3,70, n = 16), nargile (%3,94, n = 17), puro (%1,39, n = 6) ve diğer tütün ürünleri yer alıyordu.

Sigara bırakma polikliniğinde uygulanan tedavi yöntemlerinin dağılımı Tablo 3'te sunulmuştur. Hasta başına yüz yüze görüşme sayısı 1 ile 8 arasında değişiyordu. Sigarayı bırakamayan hastalar, başarıyla bırakanlara kıyasla anlamlı derecede daha az seansa katılmıştı (p < 0,001) ve anlamlı derecede daha yüksek FNBT puanlarına sahipti (p = 0,024). Sigara içme özellikleri, tedavi yaklaşımları ve bırakma sonuçlarına ilişkin ayrıntılı karşılaştırmalar Tablo 4'te sunulmuştur.

Kombine tedavi en yüksek bırakma oranlarıyla ilişkili olup diğer tüm tedavi seçeneklerinden anlamlı derecede üstündü (p < 0,001). Tedavi türleri ile sigara bırakma

sonuçlarının karşılaştırması, bupropion monoterapisi referans kategori olarak alınarak Tablo 5'te sunulmuştur. Farmakolojik tedavi almayan hastalarda bırakma olasılığı bupropion ile tedavi edilenlere göre 2,76 kat daha yüksek olmasına rağmen bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi ($p = 0,075$). Lojistik regresyon analizi, hanede sigara içen başka birinin bulunmasının bırakma olasılığını anlamlı derecede azalttığını ($p = 0,003$), hanede sigara içen kimsenin olmamasının ise bırakma olasılığını

neredeyse iki katına çıkardığını ($\text{Exp}(B) = 1,953$) ortaya koydu. FNBT puanı, bırakma başarısının anlamlı bir negatif öngörücüsüydu ($B = -0,022$, $p = 0,023$); bu, daha yüksek nikotin bağımlılığının daha düşük bırakma oranlarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Sigaraya bağlı yakınmanın olmaması bırakma başarısıyla pozitif ilişkiliydi ($B = 0,489$, $p = 0,026$) ve yakınma bildirenlere kıyasla 1,63 kat daha yüksek bırakma olasılığına karşılık geliyordu. İleri analizler Tablo 6'da sunulmuştur.

Tablo 3. Katılımcıların kullandığı tedavi seçenekleri

Tedavi kategorisi	Spesifik tedavi	n	%
Monoterapi	Vareniklin monoterapisi	18	(4,51)
	Bupropion monoterapisi	109	(27,32)
	Sitizin monoterapisi	34	(8,52)
	NRT monoterapisi	80	(20,05)
Farmakolojik	Kombine tedavi	141	(35,34)
Farmakolojik olmayan	Farmakolojik olmayan tedavi	17	(4,26)
Toplam katılımcı		399	(100,00)
Spesifik kombine tedavi seçenekleri (Toplam n=141)		n	%
	Bupropion + NRT	125	(88,65)
	Vareniklin + NRT	14	(9,93)
	Sitizin + NRT	1	(0,71)
	Vareniklin + Bupropion + NRT	1	(0,71)

Tablo 4. Sigara içme ve tedaviye ilişkin belirli parametrelerin sigara bırakma durumu ile karşılaştırılması

Özellik	Bırakma durumu	Ortalama $\pm$ SS	Ortanca (Min–Maks)	p değeri
Görüşme sayısı	Başarısız	1,96 $\pm$ 1,17	2 (1–6)	<0,001
	Başarılı	2,83 $\pm$ 1,33	3 (1–8)	
FNBT puanı	Başarısız	5,85 $\pm$ 2,40	6 (0–10)	24
	Başarılı	5,26 $\pm$ 2,52	5 (0–10)	
Sigara tüketimi (paket-yıl)	Başarısız	28,12 $\pm$ 17,43	26,5 (1,5–100)	550
	Başarılı	26,66 $\pm$ 15,25	24 (1–72)	

Tablo 5. Tedavi yöntemlerinin sigara bırakma durumu ile karşılaştırılması

Tedavi yöntemi	Bırakma durumu	Başarısız n (%)	Başarılı n (%)	p değeri
Monoterapi	Vareniklin	10 (55,55)	8 (44,45)	<0,001
	Bupropion	91 (83,48)	18 (16,52)	
	Sitizin	22 (64,70)	12 (35,30)	
	NRT	50 (62,50)	30 (37,50)	
Kombine tedavi	Kombine tedavi	79 (56,02)	62 (43,98)	
Farmakolojik tedavi yok	Yalnızca farmakolojik olmayan tedavi	11 (64,70)	6 (35,30)	

*Tüm tedavi grupları arasındaki karşılaştırmada Ki-kare testi kullanılmıştır.

Tablo 6. Sigara bırakma durumunu öngören tedavi yöntemleri ve ilişkili özelliklerin ileri analizi (lojistik regresyon)

Değişken	Kategori	B (Katsayı)	S.H. (Standart hata)	Wald χ^2	p değeri	Exp(B) (Odds oranı)
Tedavi yöntemi (Referans: Bupropion monoterapisi)						
	Vareniklin monoterapisi	1,397	540	6,697	0,010	4,044
	Sitizin monoterapisi	1,014	442	5,267	0,022	2,758
	NRT monoterapisi	1,110	346	10,272	0,001	3,033
	Kombine tedavi	1,378	309	19,924	<0,001	3,968
	Farmakolojik tedavi yok	1,014	569	3,174	0,075	2,758
Hanede başka sigara içen (Referans: Evet)						
	Hanede başka sigara içen yok	669	225	8,823	0,003	1,953
Sigaraya bağlı yakınma (Referans: Var)						
	Sigaraya bağlı yakınma yok	489	220	4,932	0,026	1,630

Tartışma

Bu çalışmada, bir sigara bırakma polikliniğine başvuran bireylerin özelliklerini analiz ettik ve bırakma başarısını etkileyen faktörleri araştırdık. Bulgularımız; vareniklin, sitizin, nikotin replasman tedavisi (NRT) ve kombine tedavilerin, en az etkili seçenek olan bupropion monoterapisine kıyasla bırakma oranlarını anlamlı derecede artırdığını göstermektedir. Daha düşük FNBT puanları ve hanede sigara içen kimsenin olmaması, daha yüksek bırakma başarısıyla ilişkiliydi.

Özellikle vareniklin monoterapisinin sigara bırakma olasılığını bupropiona kıyasla yaklaşık dört kat artırdığı bulundu ($p = 0,010$). Bu bulgu, literatürde vareniklinin bupropion ve tek ajanlı NRT'ye üstün etkinliğini gösteren büyük ölçekli meta-analizler ve randomize kontrollü çalışmalar (RKÇ) ile uyumludur.^[15] Vareniklinin $\alpha\beta 2$ nikotinik asetilkolin reseptöründeki parsiyel agonist aktivitesinin nikotin isteğini (craving) ve yoksunluk belirtilerini azaltırken aynı zamanda nikotinin ödüllendirici etkilerini zayıflattığı ve böylece bırakma oranlarını artırdığı düşünülmektedir.^[16]

Benzer şekilde sitizin ve NRT monoterapisi, bupropiona kıyasla bırakma olasılığını yaklaşık üç kat artırdı. Vareniklinle benzer etki mekanizmasına sahip, maliyet-etkin bir parsiyel agonist olan sitizin Doğu ve Orta Avrupa'da yaygın olarak kullanılmaktadır. Klinik çalışmalardan elde

edilen kanıtlar sitizinin plaseboya üstünlüğünü ve NRT ile karşılaştırılabilir etkinliğini doğrulamıştır.^[17] Bulgularımız sitizini bupropiona uygun bir alternatif olarak desteklemektedir. En yüksek bırakma oranları kombine tedavi alan hastalarda gözlemlendi; bu hastalarda bırakma olasılığı bupropion grubuna göre yaklaşık dört kat daha yüksekti. Bu bulgu, monoterapi başarısız olduğunda veya bağımlılık şiddetli olduğunda uzun etkili NRT (bant) ile kısa etkili NRT (sakız veya pastil) ya da vareniklin ile bupropion kombinasyonu gibi kombine rejimleri öneren güncel klinik kılavuzları desteklemektedir.^[18-20] Kombine yaklaşımlar birbirini tamamlayan mekanizmalar aracılığıyla etki eder, daha stabil nikotin düzeyleri sağlar ve akut nikotin isteğinin daha etkili yönetilmesine yardımcı olur. Sonuçlarımız; vareniklin alan hastaların bupropion alanlara göre 1. ve 2. haftalarda ve 1., 3. ve 6. aylarda daha yüksek bırakma oranlarına sahip olduğunu, ancak 12. ayda anlamlı fark gözlenmediğini bildiren Benli ve ark. ile uyumludur.^[21] Yakın tarihli büyük ölçekli Avusturalya çalışmaları sitizin ile vareniklini karşılaştırmış ve sitizinin benzer etkinlik gösterirken daha düşük yan etki insidansı ve daha düşük maliyet sunduğunu bildirmiştir; bu durum sitizini kaynakları kısıtlı ortamlarda uygun bir seçenek haline getirmektedir.^[22] Rigotti ve arkadaşları, 810 katılımcılı randomize klinik çalışmalarında sitizinin plaseboya kıyasla anlamlı derecede daha yüksek bırakma oranları sağladığını göstermiştir.^[23]

Bir diğer önemli bulgu, davranışsal desteğin etkisidir. Yüz yüze danışmanlık seanslarının sayısının bırakma başarısıyla anlamlı derecede ilişkili olduğu, daha fazla seansa katılan hastaların daha yüksek bırakma oranlarına ulaştığı bulundu ($p < 0,001$). Bu gözlem, daha sık takip vizitlerinin sonuçları iyileştirdiğini gösteren önceki çalışmalarla uyumludur.^[24,25] Kohortumuzda hasta başına ortalama danışmanlık seansı sayısı $2,21 \pm 1,28$ idi; bu bulgu, yoğun davranışsal desteğin sürdürülebilir bırakma için kritik önem taşıdığı görüşünü desteklemektedir.

Özellikle dikkat çekici bir gözlem, hanede sigara içen başka birinin bulunmasının bırakma başarısını anlamlı derecede azaltması, hanede sigara içen kimsenin olmamasının ise bırakma olasılığını neredeyse iki katına çıkarmasıydı. Bu bulgu, bırakma sürecinde sosyal ve çevresel faktörlerin önemini vurgulamaktadır. Literatür, eşin veya hane üyelerinin sigara içmesinin hem bir tetikleyici hem de motivasyon önünde bir engel işlevi gördüğünü ve böylece bırakma başarı oranlarını düşürdüğünü göstermektedir.^[26]

FNBT ile ölçülen nikotin bağımlılığının şiddeti de bırakma sonuçlarının anlamlı bir öngörücüsüydü; bu, tedavi arayan sigara içicilerinde ortalama puanın yaklaşık 5 olduğunu bildiren önceki çalışmalarla uyumludur.^[27] Kohortumuzda ortalama FNBT puanı $5,66 \pm 2,43$ idi ve daha yüksek puanlar bırakma başarısıyla negatif ilişkiydi; bu durum, yüksek bağımlılığı olan bireyler için daha yoğun farmakolojik ve davranışsal müdahalelere olan ihtiyacı ortaya koymaktadır.^[28-30]

İlginç bir şekilde, sigaraya bağlı yakınması olmayan katılımcıların, semptomu olanlara kıyasla 1,63 kat daha yüksek bırakma olasılığına sahip olduğu bulundu. Sağlık kaygılarının sıklıkla bırakmanın birincil motivasyon kaynağı olarak gösterildiği düşünüldüğünde bu durum sezgiye aykırı görünebilir; olası bir açıklama, asemptomatik bireylerin anlık tepkisel korkudan ziyade uzun vadeli sağlığı koruma amacıyla daha proaktif ve içsel bir bırakma motivasyonuna sahip olabileceğidir. Otonom motivasyonun, dışsal motivasyonla yapılan girişimlere kıyasla daha sürdürülebilir davranış değişikliğiyle sonuçlandığı gösterilmiştir.^[31] Bir diğer olası açıklama ise kronik hastalığı veya semptomları olan bireylerin sigarayı bir başa çıkma mekanizması olarak kullanabilmesi ve bunun bırakmayı zorlaştırabilmesidir.

Son olarak, çalışmamız sonuçları ilaçların ücretsiz sağlanıp sağlanmadığına göre ayrıntılı olarak incelememiş olsa da önceki araştırmalar, farmakoterapinin ücretsiz

sağlanmasının tedaviye uyumu ve sigara bırakma başarısını artırdığını göstermiştir.^[32] Analizimizde maliyetle ilgili verilerin bulunmaması olası bir karıştırıcı faktör oluşturabilir.

Kısıtlılıklar

Bu bulgular yorumlanırken birkaç kısıtlılık göz önünde bulundurulmalıdır. Birincisi, hasta görüşmelerini yürüten asistan hekimlerin değişmesi nedeniyle (eğitim programları arasındaki rotasyonlardan kaynaklanan bir zorunluluk) hasta uyumunda kesintiler yaşanmış olabilir ve bu durum bazı katılımcılar için öz bildirime dayalı sigara bırakma durumunun doğruluğunu etkilemiş olabilir. İkincisi, standart dosyalama sistemine ek olarak eksik verilerin kaydedilmesinde telefon görüşmelerine ve hasta öz bildirimine dayanılması, veri bütünlüğü ve nesnellik açısından bir kısıtlılık oluşturmaktadır. Son olarak, vareniklinin (piyasadan çekilmesi nedeniyle) temin edilememesi ve ardından sitizinin kullanıma girmesi, çalışma dönemi boyunca terapötik ilaç seçim sürecini önemli ölçüde etkilemiştir.

Güçlü yönler

Bu çalışma, bildiğimiz kadarıyla sitizin ile sigara bırakma tedavisini ele alan erişilebilir ilk tez çalışması olması bakımından dikkate değer bir güçlü yön sunmaktadır. Ayrıca bupropion, vareniklin, sitizin ve Nikotin Replasman Tedavisi (NRT) dahil çeşitli tedavi yöntemlerinden elde edilen sonuçları kapsayan geniş yapısı, bu çalışmayı alana değerli bir katkı haline getirmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Kombine tedavi alan hastalarda sigara bırakma oranları, monoterapi veya diğer tedavi seçeneklerini kullananlara göre daha yüksek bulundu. Artan tedavi uyumu ile daha yüksek bırakma oranları arasında pozitif bir korelasyon gözlemlendi. Bu bağlamda, tedavi seansları sırasında hastaların sigara bırakma motivasyonunu artırmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması önerilmektedir.

Etik onay

Çalışma protokolü Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu tarafından onaylanmıştır (Onay No: 2023/18/10, 4 Ekim 2023 tarihli). Tüm hastalardan ilk vizitlerinde yazılı bilgilendirilmiş onam alınmıştır.

Yazar katkısı

Yazarlar makaleye katkılarını şu şekilde beyan etmektedir: Çalışmanın kavramsallaştırılması ve tasarımı: OÖ, Veri toplama: EC, Sonuçların analizi ve yorumlanması:

EC, Taslak makalenin hazırlanması: AG, OÖ, EC. Tüm yazarlar sonuçları gözden geçirmiş ve makalenin son halini onaylamıştır.

Finansman kaynağı

Yazarlar, çalışmanın herhangi bir finansman desteği almadığını beyan etmektedir.

Çıkar çatışması

Yazarlar, açıklanması gereken herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan etmektedir.

Kaynaklar

1. Le Foll B, Piper ME, Fowler CD, et al. Tobacco and nicotine use. Nat Rev Dis Primers. 2022;8(1):19. [Crossref]
2. Timilsina JK, Bhatta B, Devkota A. Nicotine dependence and quitting stages of smokers in Nepal: a community based cross-sectional study. PLoS One. 2022;17(4):e0266661. [Crossref]
3. Çelik M, Erdoğan A. Epidemiology of tobacco use. Türkiye Klinikleri Family Medicine - Special Topics. 2016;7(5):5-12.
4. Summers AD, Sirin H, Palipudi K, Erguder T, Ciobanu A, Ahluwalia IB. Changes in prevalence and predictors of tobacco smoking and interest in smoking cessation in Turkey: Evidence from the Global Adult Tobacco Survey, 2008-2016. Tob Prev Cessat. 2022;8:35. [Crossref]
5. Öztürk O, Selçuk MY, Bektaş MY, Ünal M. Self-control, everything for smoking cessation? Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 2016;10(1):4-5. [Crossref]
6. 2.5 million people received services from smoking cessation polyclinics. Available at: <https://www.aa.com.tr/tr/saglik/sigarayi-birakma-polikliniklerinden-2-5-milyon-kisi-hizmet-aldi/1533870> (Accessed on Sep 25, 2025).
7. Fidanci I, Ozturk O, Unal M. Transtheoretic Model in smoking cessation. J Exp Clin Med. 2017;34(1):9-13.
8. Argüder Y, Kılınç O, Rezene M, Abadoğlu O, S. One-year smoking cessation outcomes of patients admitted to our smoking cessation clinic. Eurasian J Pulmonol. 2014;16(1):16-21
9. Karadoğan D, Önal Ö, Şahin DS, Kanbay Y, Alp S, Şahin Ü. Treatment adherence and short-term outcomes of smoking cessation outpatient clinic patients. Tob Induc Dis. 30;16:38. [Crossref]
10. Choi SH, Duffy SA. Analysis of health behavior theories for clustering of health behaviors. J Addict Nurs. 2017;28(4):203-209. [Crossref]
11. Ezika E. Use of transtheoretical model to facilitate physical activity and promote cardiovascular health knowledge in an urban community setting. Int J Sci Res Arch. 2024;11(1):304-315. [Crossref]
12. McDonough M. Update on medicines for smoking cessation. Aust Prescr. 2015;38(4):106-111. [Crossref]
13. Heatherton TF, Kozlowski LT, Frecker RC, Fagerström KO. The Fagerström test for nicotine dependence: a revision of the Fagerström Tolerance Questionnaire. Br J Addict. 1991;86(9):1119-1127. [Crossref]
14. Uysal M, Kadakal F, Karşıdağ Ç, Bayram N, Uysal O, Yılmaz V. Fagerström test for nicotine dependence: reliability in a Turkish sample and factor analysis. Tuberk Toraks. 2004;52(2):175-182.
15. Cahill K, Stevens S, Perera R, Lancaster T. Pharmacological interventions for smoking cessation: an overview and network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2013;2013(5):CD009329. [Crossref]
16. Anthenelli RM, Benowitz NL, West R, et al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet. 2016;387(10037):2507-2520. [Crossref]
17. Walker N, Howe C, Glover M, et al. Cytisine versus nicotine for smoking cessation. N Engl J Med. 2014;371(25):2353-2362. [Crossref]
18. Koegelenberg CFN, Noor F, Bateman ED, et al. Efficacy of varenicline combined with nicotine replacement therapy vs varenicline alone for smoking cessation: a randomized clinical trial. JAMA. 2014;312(2):155-161. [Crossref]
19. Lancaster T, Stead LF. Individual behavioural counselling for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2017;3(3):CD001292. [Crossref]
20. Patel MS, Patel SB, Steinberg MB. Smoking cessation. Ann Intern Med. 2021;174(12):ITC177-ITC192. [Crossref]
21. Benli AR, Erturhan S, Oruc MA, Kalpakci P, Sunay D, Demirel Y. A comparison of the efficacy of varenicline and bupropion and an evaluation of the effect of the medications in the context of the smoking cessation programme. Tob Induc Dis. 2017;15:10. [Crossref]
22. Courtney RJ, McRobbie H, Tutka P, et al. Effect of cytisine vs varenicline on smoking cessation: a randomized clinical trial. JAMA. 2021;326(1):56-64. [Crossref]
23. Rigotti NA, Benowitz NL, Prochaska J, et al. Cytisinicline for smoking cessation: a randomized clinical trial. JAMA. 2023;330(2):152-160. [Crossref]
24. Yılmaz A, Turan A. General characteristics of our patients in smoking cessation treatment and factors affecting treatment success. Izmir Chest Hospital Journal. 2015;3(29):145-149.

25. Arpacioğlu S, Ünübol B, Erzincan E, Bilici R. Results of the Erenköy Psychiatric And Neurological Diseases Hospital smoking cessation clinic: investigation of the effectiveness of cognitive behavioral intervention and pharmacotherapy. *Addicta: The Turkish Journal on Addictions*. 2019;6(4):295-231. [\[Crossref\]](#)
26. Park EW, Schultz JK, Tudiver F, Campbell T, Becker L. Enhancing partner support to improve smoking cessation. *Cochrane Database Syst Rev*. 2004;(3):CD002928. [\[Crossref\]](#)
27. Davis JM, Masclans L, Rose JE. Adaptive smoking cessation using precessation varenicline or nicotine patch: a randomized clinical trial. *JAMA Netw Open*. 2023;6(9):e2332214. [\[Crossref\]](#)
28. Górecka D, Bednarek M, Nowiński A, Puścińska E, Goljan-Geremek A, Zieliński J. Diagnosis of airflow limitation combined with smoking cessation advice increases stop-smoking rate. *Chest*. 2003;123(6):1916-1923. [\[Crossref\]](#)
29. Vangeli E, Stapleton J, Smit ES, Borland R, West R. Predictors of attempts to stop smoking and their success in adult general population samples: a systematic review. *Addiction*. 2011;106(12):2110-2121. [\[Crossref\]](#)
30. Uzer F, Uzun R. General health status and smoking cessation rates of individuals admitted to the smoking cessation outpatient clinic. *Thorac Res Pract* 2019;20(1):113.
31. Curry S, Wagner EH, Grothaus LC. Intrinsic and extrinsic motivation for smoking cessation. *J Consult Clin Psychol*. 1990;58(3):310-316. [\[Crossref\]](#)
32. Aksel O, Küçüktepe N, Yaslıca Z, Başak O. Providing free access to smoking cessation medications: does it have an impact on the treatment adherence and success of smoking cessation? *Turk Thorac J*. 2021;22(3):224-230. [\[Crossref\]](#)